EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79874
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-01 12:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ESTEPHANIA PATRICIA GUERRERO SEREY			RUN	: 19.562.454-2
F.Nac	: 29-11-1996	Edad	: 27 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-28	Fecha Egreso	: 2024-03-01 12:31:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R73.9-HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SEPSIS FOCO NO EVIDENTE: BACTEREMIA COCACEAS GRAM + (S. PYOGENES)
HIPERGLICEMIA, 2° DMIR DESCOMPENSADA (POR CESE DE TTO)
HTA
OBESIDAD
ALERGIA A PREDNISONA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

ANTECEDENTE DE DM SIN TRATAMIENTO HACE DOS AÑOS. POSTPARTO PERDIÓ CONTROLES
CONSULTA POR CEG, FIEBRE Y CALOFRIOS. ADEMAS DOLOR HIPOGASTRIO
SE CONSTATA A SU INGRESO S. URGENCIA HSC EL 27/02/24, HD ESTABLE, GLICEMIA MAYOR A 700 SIN CAD SIN HIPEROSMOLAR, SE INICIA BIC CON INSULINA
PCR 40, LEUCOCITOS 30.000 CON DESVIACION IZQUIERDA.
CLINICAMENTE SIN FOCO INFECCIOSO DEFINIDO. EVALUACION GINECOLÓGICA NORMAL, ORINA NORMAL, TAC TAP SIN FOCO. SE INICIA TRATAMIENTO CON CEFTRIAXONA.
EN UNIDAD DE URGENCIA, EN BEG, ACTIVA, HIDRATADA, HD AUTOSOSTENIDA, NORMOSATURANDO, AFEBRIL
SE INGRESA PARA TTO ATB Y ESTUDIO, PREINFORME DE HC EVIDENCIA COCACEAS GRAM + PACTE EN SALA EN BCG, COMPLETANDO 3 DIAS TTO ATB CEFTRIAXONA+CLOXA
NIEGA SINTOMAS, PERO PRESENTO FIEBRE LOS PRIMEROS DIAS. DESDE AYER AFEBRIL. HDN ESTABLE
HC INFORMAN (PRE: COCACEAS GRAM +), DEFINITIVO: STREPTOCOCCUS pyogenes MULTISENSIBLE.
EVALUADA POR FARMACOLOGIA CLINICA, SE PUEDE MANTENER SOLO CON CEFTRIAXONA.

**POR BUENAS CONDICIONES GENERALES, MANTENERSE ASINTOMATICA Y AFEBRIL, EXAM CON

TENDENCIA A RECUPERACION DE PARAMETROS, Y DEFINIENDO POSIBILIDAD DE ATB MONOTERAPIA, SE PLANTEA CONTINUAR EN HODOM.

PLAN DE MANEJO:

AL ALTA DE HODOM; CONTINUAR CONTROLES EN POLI MED INTERNA PARA RETOMAR SEGUIMIENTO Y COMPENSACION DE DMIR, ANTES DE SEGUIR EN APS

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. REG DIABETICO HIPOSODICO HIPOCALORICO A TOLERANCIA
3. OMEPRAZOL 20MG 1 AL DIA VO
4. CEFTRIAXONA 2 GR DIA EV, COMPLETAR 10 DIAS DE TTO
5. INS NPH 20 U AM – 10 U PM SC
6. PARACETAMOL 500 MG CADA 8/H SOS SI DOLOR O FIEBRE VO
7. DIPIRONA 300MG 1 C/8HRS SOS SI PERSISTE FIEBRE VO
8. CONTROLAR HGT 2 VECES AL DIA POR LO MENOS Y REGISTRAR

EXÁMENES Y RESULTADOS

EX LAB: 01/03: PCR 147 / LEUCO 4800
29/02: CREA 0.6/ PCR 245/ LEUCO 7500/ LACTATO 1.0/ GLICEMIA 222/ ELP OK

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO